



La Federación Salud Mental Canarias reclama una partida presupuestaria estable, un estudio sueco vincula los fármacos GLP-1 con menos ingresos psiquiátricos y un ensayo alemán logra frenar las pesadillas del estrés postraumático con THC: claves del 17 de agosto de 2026

LUNES 17 DE AGOSTO DE 2026

Resumen rápido del día

La Federación Salud Mental Canarias reclama al Parlamento autonómico una partida presupuestaria específica y estable para 2027, dirigida a sostener el Plan de Salud Mental del archipiélago. La Confederación Salud Mental España publica un reportaje sobre el impacto del gaming en el bienestar emocional de los jóvenes, con testimonios de jugadoras, jugadores y profesionales de la psicología. Un estudio sueco publicado en *The Lancet Psychiatry* vincula el uso de fármacos GLP-1, como la semaglutida, con una reducción de las hospitalizaciones y bajas laborales por causas psiquiátricas en personas con depresión o ansiedad. Un estudio estadounidense en *Neurology® Open Access* asocia el control de la hipertensión, la diabetes y el tabaquismo en la mediana edad con hasta 13 años más de vida libre de demencia. Un ensayo alemán publicado en *Nature Medicine* logra eliminar por completo las pesadillas del trastorno de estrés postraumático en más de un tercio de las personas tratadas con dronabinol.

NORMATIVA · NACIONAL

La Federación Salud Mental Canarias reclama una partida presupuestaria estable para 2027

La Federación Salud Mental Canarias, entidad que representa al movimiento asociativo de salud mental en el archipiélago, ha iniciado una ronda de interlocución formal con las portavocías de los siete grupos con representación en el Parlamento autonómico: Nacionalista Canario, Popular, Socialista Canario, Nueva Canarias-Bloque Canarista, Agrupación Socialista Gomera, Vox y Mixto. La Federación les ha presentado una propuesta técnica que solicita la inclusión, en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2027, de una partida económica específica, nominada y finalista, vinculada orgánica y funcionalmente a la Dirección General de Salud Mental y Adicciones. Según explica Miguel Tomé Pueyo, vicepresidente de la Federación, estos fondos no se solicitan para cubrir obligaciones ordinarias o estructurales del sistema sanitario público, sino para desarrollar líneas estratégicas del Plan de Salud Mental de Canarias, entre ellas la promoción de la salud mental, la prevención de la conducta suicida, la reducción del estigma, la coordinación intersectorial y la formación e investigación. La Federación recuerda que el Plan de Salud Mental de Canarias 2019-2023 sí contó en su día con una ficha financiera específica, con una inversión complementaria de 2.556.566 euros anuales, y que desde entonces, y pese a que han transcurrido más de tres años desde la creación de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones, no existe una dotación presupuestaria diferenciada y estable en las cuentas autonómicas. La propuesta ha sido remitida también a la Presidencia del Gobierno de Canarias, la Presidencia del Parlamento y la Consejería de Sanidad.

Fuente: Federación Salud Mental Canarias / Confederación Salud Mental España

SALUD PÚBLICA · NACIONAL

Un reportaje de Salud Mental España analiza el impacto del gaming en el bienestar de los jóvenes

La Confederación Salud Mental España ha publicado, en el primer número de 2026 de su Revista Encuentro, un reportaje sobre el mundo del gaming y su impacto en el bienestar emocional de las personas jóvenes. Según datos del Ministerio de Sanidad citados en el reportaje, el uso de videojuegos se mantiene muy extendido entre la población joven, con un 84,4 % de práctica de juego. De acuerdo con el Informe sobre adicciones comportamentales y otros trastornos adictivos, también citado en el texto, un 8,6 % de los estudiantes hombres podría presentar una posible adicción a los videojuegos, frente a un 1,8 % en el caso de las mujeres. La psicóloga clínica Alejandra Julio Berrio, entrevistada en el reportaje, explica que existe un uso problemático cuando el juego se convierte en un regulador emocional, de forma que se produce una pérdida de control que puede provocar ansiedad e interferir en aspectos como el sueño o la alimentación. El reportaje recoge también testimonios de jóvenes jugadoras y jugadores, entre ellos varias creadoras de contenido, que describen tanto el papel del gaming como fuente de apoyo emocional y comunidad como los riesgos asociados a la toxicidad en los chats de juego, un fenómeno que, según el estudio Women Gamers Report citado en el texto, ha tenido un impacto negativo en la salud mental del 19 % de las mujeres que lo han sufrido. La psicóloga subraya que la clave para un uso saludable pasa por el control del tiempo, la incorporación de otros hábitos de bienestar y el acompañamiento familiar desde la comprensión y no desde el miedo.

Fuente: Confederación Salud Mental España, Revista Encuentro

Noticias internacionales

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

Un estudio sueco vincula los fármacos GLP-1 con menos hospitalizaciones psiquiátricas en depresión y ansiedad

Un estudio observacional realizado por investigadores del Instituto Karolinska de Suecia, la Universidad del Este de Finlandia y la Universidad Griffith de Australia, publicado en The Lancet Psychiatry, ha analizado la relación entre el uso de fármacos agonistas del receptor GLP-1 –utilizados habitualmente para tratar la diabetes y la obesidad, como la semaglutida o la liraglutida– y el riesgo

de hospitalización o baja laboral por motivos psiquiátricos en personas con depresión o ansiedad. El estudio incluyó a más de 95.000 personas diagnosticadas con depresión o ansiedad a las que se había prescrito algún antidiabético, de las cuales 22.480 habían usado fármacos GLP-1, y siguió a los participantes a través de los registros nacionales suecos entre 2009 y 2022, comparando periodos de uso y de no uso de la medicación en las mismas personas. Los resultados muestran que, durante los periodos de uso de semaglutida, el riesgo de necesitar atención hospitalaria o baja laboral por causas psiquiátricas se redujo un 42 % con respecto a los periodos sin uso: un 44 % menos de riesgo por depresión, un 38 % menos por ansiedad y un 47 % menos por trastorno por uso de sustancias. La liraglutida se asoció a una reducción del 18 % del riesgo, sin una reducción clara en ansiedad. Jari Tiihonen, autor principal del estudio, señala que, al tratarse de un estudio observacional, son necesarios ensayos clínicos controlados para confirmar estos resultados.

Fuente: Karolinska Institutet / The Lancet Psychiatry

Publicaciones científicas recientes

Roepke, S., et al. (2026). Dronabinol for nightmares in post-traumatic stress disorder: A randomized controlled trial. Nature Medicine.

DOI: [10.1038/s41591-026-04546-9](https://doi.org/10.1038/s41591-026-04546-9)

Hallazgo: Un ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, liderado por investigadores de la Charité – Universitätsmedizin Berlin y publicado el 5 de agosto de 2026 en Nature Medicine, ha evaluado el dronabinol –un medicamento con receta elaborado a partir del delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) del cannabis– para el tratamiento de las pesadillas asociadas al trastorno de estrés postraumático (TEPT). Participaron 171 personas adultas con TEPT y pesadillas recurrentes (edad media de 37,9 años; 79,3 % mujeres), de las cuales 87 recibieron dronabinol, en dosis de entre 2,5 y 15 miligramos una vez al día antes de dormir, y 84 recibieron placebo, durante diez semanas. A las diez semanas, la reducción en la puntuación CAPS-IV B2, que mide la frecuencia e intensidad de las pesadillas, fue significativamente mayor en el grupo de dronabinol que

en el de placebo (diferencia entre grupos de $-1,50$; $p < 0,001$). El 57,9 % de las personas del grupo de dronabinol redujo sus pesadillas al menos a la mitad, frente al 29 % del grupo placebo, y más de un tercio de quienes tomaron dronabinol dejó de tener pesadillas por completo. El fármaco no mejoró de forma significativa la gravedad global del TEPT ni los síntomas depresivos asociados, y los efectos secundarios registrados fueron mayoritariamente leves.

Implicación clínica: Los autores destacan que se trata del ensayo más riguroso realizado hasta la fecha sobre un fármaco cannabinoide para este síntoma específico del TEPT, aunque subrayan que sus efectos se limitan a las pesadillas y no se extienden a la sintomatología global del trastorno. Los resultados sugieren que el dronabinol podría constituir una opción terapéutica específica para las pesadillas relacionadas con el trauma en personas que no responden a otros tratamientos, si bien no sustituye a los abordajes psicológicos y psicoterapéuticos dirigidos al conjunto de síntomas del TEPT.

Prioridades del día

Revisar el cribado de factores de riesgo vascular en valoraciones neuropsicológicas de mediana edad

A la luz de los datos observacionales publicados en *Neurology® Open Access* sobre la relación entre hipertensión, diabetes y tabaquismo en la mediana edad y los años de vida libres de demencia, puede ser útil incorporar una revisión sistemática de estos tres factores de riesgo vascular en las valoraciones neuropsicológicas de personas entre 45 y 65 años, coordinando cuando proceda con el médico de familia o el especialista correspondiente.

Incorporar el gaming como tema habitual en la evaluación y el trabajo con adolescentes y familias

Dado que el uso de videojuegos está muy extendido entre la población joven y que el reportaje de la Confederación Salud Mental España señala que el uso

problemático aparece cuando el juego se convierte en regulador emocional, puede ser relevante preguntar de forma habitual por los hábitos de juego en las primeras entrevistas con adolescentes y explorar con las familias el acompañamiento desde la comprensión, evitando un enfoque exclusivamente restrictivo.

Tener en cuenta el tratamiento con fármacos GLP-1 al valorar síntomas depresivos o ansiosos

Ante los resultados observacionales del estudio sueco publicado en The Lancet Psychiatry, puede ser oportuno preguntar en la anamnesis si la persona está en tratamiento con fármacos GLP-1 cuando presente diabetes u obesidad junto con depresión o ansiedad, sin extraer conclusiones definitivas de un solo estudio observacional y manteniendo el criterio clínico y la coordinación con el equipo médico.